Número do processo: 0710677-30.2024.8.07.0004

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: TAINARA DAVIDIS ROCHA

REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Cuida a hipótese de ação processada sob o rito ordinário, proposta por TAINARA DAVIDIS ROCHA em desfavor da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, CASSI, onde se requer o deferimento da tutela de urgência para que seja, *inaudita altera pars*, para que o plano de saúde Requerido seja compelido a autorizar e custear o tratamento o tratamento fármaco-hospitalar Belynsta 120mg 6 frascos de belimumabe ev em dose de indução semanais 0, 3 e 4 por vez e, manutenção mensal ev de 6F, nos moldes propostos pelo médico, nos moldes determinados pelo médico especialista, enquanto perdurar a necessidade, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Sustenta a Autora que é beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com **Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)** e que houve negativa **de cobertura do medicamento Belimumabe (Benlysta)**, prescrito por sua médica assistente como tratamento necessário, diante de insucesso com outras terapias e da condição clínica da paciente.

A parte autora relata que, após falhas terapêuticas com outros medicamentos e efeitos adversos graves, o uso do **Belimumabe** foi indicado como tratamento adequado e imprescindível, inclusive por apresentar menor risco para futura gestação. Informa que o fármaco está **devidamente registrado na ANVISA**, tem **eficácia comprovada**, e sua indicação consta em bula para o tratamento da patologia que a acomete (LES), de modo que a recusa do plano de saúde é considerada **abusiva e ilegal**.

Alega-se que a negativa viola os princípios da boa-fé contratual, dignidade da pessoa humana e direito à saúde, e que não cabe à operadora do plano substituir a indicação médica. Requer a concessão de **tutela de urgência**, com a imposição ao plano de saúde de fornecer o medicamento nas doses prescritas (Benlysta 120 mg – 6 frascos mensais), sob pena de multa diária, além da **condenação definitiva** ao custeio integral do tratamento enquanto perdurar a necessidade médica.

Fundamenta o pedido nas Leis nº **9.656/98** e **14.307/2022**, bem como em precedentes do **STJ e TJDFT**, que reconhecem a possibilidade de cobertura de medicamentos não constantes do rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais, como é o caso dos autos.

O valor atribuído à causa é de **R$ 98.208,00**.

Houve emenda à inicial, onde a Autora assevera que que o mesmo número indicado na mensagem, qual seja 201 04 391 consta do print acostado ao id nº 207234309, e no intuito de que não obtivesse nenhuma dúvida a respeito, a requerente abriu chamado no plano de saúde e solicitou esclarecimento, obtendo como resposta a justificativa de que o uso solicitado está fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. Conforme a Resolução Normativa/ANS 465/2021, a cobertura do procedimento é obrigatória apenas em casos específicos.

No que se refere ao relatório médico, requer a juntada de documento hábil a comprovar que a Requerente necessita da presente medicação em caráter de urgência, pois ela é fundamental para redução e retirada de corticoides, o qual provoca efeitos colaterais, e que a cada recidividada, ou seja recaída da doença, a exemplo deste momento, requer doses elevadas de

corticoides, acarretando o risco de lesão renal e iminente. De acordo com o referido relatório, destaca-se ainda, que os exames laboratorias anexos demonstram a ativação/retorno da doença, necessitando assim da liberação imediata da medicação para dar qualidade de vida à paciente/autora.

Requer a juntada do respectivo relatorio, o qual demonstra que a variável contida no exame laboratorial carreado ao id 207861981 apta a comprovar que a recidividada, ou seja recaída da doença é denominado de AntiDNA, cujos indices encontram-se devidamente especificados.

Foi concedida tutela antecipada nos seguintes termos:

"Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por **TAINARA DAVIDIS ROCHA** em face de **CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASILCASSI,** com pedido de Tutela de Urgência para determinar que a requerida seja compelida a autorizar e custear o tratamento fármaco-hospitalar Belynsta 120mg 6 frascos de belimumabe ev em dose de indução semanais 0, 3 e 4 por vez e, manutenção mensal ev de 6F, nos moldes propostos pelo médico.

Narra a parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida desde o ano de 2017; que é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES CID – M32.1; que desde 2023 vem tendo recaídas da doença; que em razão da atividade da doença a médica assistente prescreveu o uso de Belynsta 120mg 6 frascos de belimumabe ev dose de indução semanais 0,3 e 4 por vez e, manutenção mensal ev de 6F; que o pedido de autorização do tratamento médico foi negado pela operadora.

Diante desses fatos, pugna pela concessão de tutela de urgência.

É o relatório do essencial. Decido.

A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei nº 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

A tutela de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando o caderno processual, vislumbro a plausibilidade do direito do autor, consubstanciada pelo relatório médico de ID 207343403 (https://pje-interno.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/1g/3921429/207343403) e pelo laudo de ID 208201070 (https://pje-interno.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/1g/3921429/208201070), que atestam a necessidade do tratamento e, ainda, pelo documento de ID 207861973 (https://pje-interno.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/1g/3921429/207861973), que comprova a negativa do plano de saúde para autorizar o medicamento.

A prova documental indica que o quadro clínico da requerente evidencia a necessidade do medicamento, pois o tratamento apenas com os medicamentos anteriormente prescritos, "vem evoluindo com piora clínica", sendo, pois, indicado associação com o medicamento Benlysta.

Destarte, considerando que cabe ao médico assistente do requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes constato, pois, a presença da probabilidade do direito.

De outro lado, o perigo de dano se justifica, em razão de que a demora ordinária no fornecimento do tratamento pode comprometer ainda mais o quadro clínico da requerente, do que emerge a urgência do caso.

Destaco que a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, sendo julgada improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode ser efetuada a cobrança de eventuais valores devidos pela parte autora em razão dos serviços prestados pela requerida.

Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, FORNEÇA E DISPONIBILIZE À PARTE REQUERENTE O MEDICAMENTO Belynsta 120mg 6 frascos de belimumabe ev em dose de indução semanais 0, 3 e 4 por vez e, manutenção mensal ev de 6F, nos moldes propostos pelo médico (ID 207343403 (https://pje-interno.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/1g/3921429/207343403)).

A medida, ora deferida, deverá ser cumprida no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30(trinta) dias.

Ainda que paire dúvida sobre o âmbito de cobertura do plano de saúde, reputo que ela há de ser resolvida em favor do direito à saúde.

Embora o requerido seja parceiro eletrônico, para garantir o mais rápido cumprimento da presente decisão, determino a intimação/citação por Oficial de Justiça, **em regime de urgência.**

Confiro a esta decisão força de mandado.

Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de promovê-la oportunamente.

Assim, CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC).

Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.

Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços.

Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito."

A parte Requerida informa o cumprimento da decisão judicial de antecipação de tutela.

A Requerida , em contestação, sustenta a legalidade da negativa de fornecimento do medicamento Benlysta, argumentando que este não possui cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tampouco está previsto contratualmente. Alega que a cobertura está condicionada às Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da RN nº 465/2021 da ANS, cujos critérios não são atendidos pela Requerente, inexistindo, portanto, obrigação contratual ou legal para o custeio do tratamento.

Afirma que a tabela do plano de saúde não contempla a cobertura do referido medicamento, o que foi previamente pactuado entre as partes, nos termos do princípio **pacta sunt servanda**, e que a ampliação da cobertura comprometeria o equilíbrio atuarial e econômico do plano, baseado no princípio da mutualidade.

A Requerida ainda ressalta a natureza **taxativa** do rol da ANS, reforçada pela Lei nº 14.307/2022, e cita jurisprudência do STJ nesse sentido. Aduz que não está obrigada a fornecer qualquer tratamento prescrito fora dos limites contratuais e regulatórios da ANS, e que não houve conduta ilícita em sua atuação.

Ao final, pleiteia a improcedência integral dos pedidos da parte autora, o reconhecimento da inaplicabilidade do CDC à relação, a condenação da Requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, bem como a realização de prova pericial por meio de parecer do NATJUS e consulta à ANS.

A parte autora, ao impugnar a contestação, destacou que, embora a ré seja operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, tal fato não afasta a obrigação contratual de custeio do tratamento prescrito, especialmente quando previsto no regulamento interno da própria operadora, que assegura cobertura de procedimentos indispensáveis ao controle da doença.

Foi reconhecido nos autos, de forma incontroversa, que: (a) a autora é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID M32.1); (b) há indicação médica para uso do medicamento **Benlysta**; (c) o medicamento é registrado pela ANVISA e indicado em bula para a doença; (d) houve insucesso com os medicamentos anteriormente utilizados; e (e) o réu não apresentou alternativa terapêutica substitutiva.

Quanto à alegação de ausência de obrigatoriedade de custeio, com base na RN nº 465/2021 da ANS, a autora argumenta que o medicamento é de uso **intravenoso e ambulatorial**, sendo, portanto, **medicação assistida**, e não domiciliar, o que afasta a exclusão contratual. Aponta, ainda, que a recusa viola a **Lei nº 14.454/2022**, que prevê cobertura obrigatória de tratamentos com comprovação científica, mesmo fora do rol da ANS, desde que prescritos por profissional habilitado.

A réplica também rechaça o argumento da taxatividade do rol da ANS, destacando que a jurisprudência atual admite exceções quando há indicação médica fundamentada e ausência de alternativas no rol, especialmente diante do risco à saúde e à vida da paciente. A recusa ao custeio do medicamento, sem oferecer tratamento alternativo, configura conduta abusiva e fere a boa-fé contratual, a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, a autora requer o desacolhimento da contestação e a procedência dos pedidos iniciais, ressaltando que os documentos apresentados não foram impugnados especificamente pela ré, o que atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

A parte Requerida informou que, em razão de alteração na regulamentação da ANS, o medicamento **Benlysta**, anteriormente negado pela ré, passou a ter **cobertura obrigatória pelos planos de saúde**, inclusive para casos clínicos como o da demandante.

Com isso, o pedido formulado na inicial **perdeu o objeto**, pois a própria ré reconheceu a nova obrigatoriedade e passou a autorizar administrativamente o fornecimento do medicamento, sem necessidade de ordem judicial.

Diante do fato superveniente, a parte autora **requereu a extinção do processo sem resolução de mérito**, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

A Autora manifestou-se no sentido de que tal fato não figura como causa superveniente capaz de ensejar a extinção do feito, por ausência de interesse processual, haja vista que, desde o dia 29 de julho de 2024 a ANS anunciou a inclusão do medicamento no Rol de procedimentos e ainda assim, houve a negativa por parte do requerido em fornecer a cobertura, sendo responsável não só pelo ajuizamento da demanda, mas por contestá-la e viabilizar que ela se prolongue até a fase de prolação da sentença. Desse modo, em garantia ao direito de saúde da Requerente, pugna pelo julgamento do feito, com a procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

Decido.

Julgo antecipadamente a lide a teor do que dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de obrigação de fazer objetivando o custeio do medicamento **Benlysta (Belimumabe)**, prescrito para o tratamento de **Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES**, em razão da negativa da operadora de plano de saúde em autorizá-lo administrativamente.

Após o deferimento de **tutela de urgência**, a parte requerida **cumpriu a determinação judicial** e passou a fornecer o medicamento.

Preliminarmente, verifica-se que não há perda do objeto conforme sustenta a parte Requerida nos autos.

Sustenta a Requerida que, com a alteração da regulamentação da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o medicamento BENLYSTA passou a ser obrigatoriamente coberto pelos planos de saúde, incluindo para os casos clínicos similares ao da parte autora. Com isso, o pedido formulado na inicial perdeu seu objeto, pois a Requerente já tem direito à cobertura do referido medicamento, conforme as novas diretrizes estabelecidas pela ANS.

Contudo, conforme bem salientou a Requerente, tal fato não figura como causa superveniente capaz de ensejar a extinção do feito, por ausência de interesse processual, haja vista que já houve a negativa por parte do requerido em fornecer a cobertura, o que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Passo ao julgamento do mérito.

FUNDAMENTAÇÃO

A relação jurídica em análise é regida pelas disposições da **Lei nº 9.656/1998**, aplicáveis aos contratos de plano de saúde, bem como pelos princípios constitucionais que garantem o **direito à saúde, à vida, à dignidade da pessoa humana e à boa-fé contratual**.

É **incontroverso nos autos** que:

- A autora é **beneficiária do plano de saúde** administrado pela requerida;
- Foi diagnosticada com **Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES (CID M32.1)**;
- Foi prescrito por médica especialista o medicamento **Belimumabe (Benlysta)**, com justificativa clínica detalhada, diante de falhas terapêuticas anteriores e efeitos adversos dos tratamentos convencionais;
- O medicamento encontra-se **regularmente registrado na ANVISA**, sendo indicado em bula para o tratamento da patologia que acomete a autora;
- Houve **recusa administrativa** da operadora em fornecer o medicamento, sob o argumento de que **não constava do rol da ANS** ou de que não preenchia os critérios das Diretrizes de Utilização Técnica – DUT;
- A ré **não indicou tratamento alternativo** e **não impugnou os documentos médicos apresentados**.

A conduta da operadora de plano de saúde, ao negar cobertura com base em **interpretação estrita e descontextualizada das normas da ANS**, revela-se **abusiva** e **contrária ao entendimento consolidado nos tribunais superiores**, que reconhecem que o **rol da ANS é meramente exemplificativo**, admitindo exceções quando **comprovada a necessidade do tratamento por profissional habilitado**, o medicamento for **registrado na ANVISA** e **não houver alternativa terapêutica igualmente eficaz**.

Neste sentido, a jurisprudência é clara:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. TRATAMENTO. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA**. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se não houver necessidade de produção de outras para a prestação da atividade jurisdicional, o indeferimento da diligência requerida pelo réu e o consequente julgamento antecipado do mérito não caracterizam cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, e foi diagnosticada com lúpus erimatoso sistêmico. Após se submeter a tratamento com outros fármacos, e ter apresentado quadro clínico refratário, foi indicado o medicamento Belimumabe (Benlysta) pelo médico reumatologista. 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear o fornecimento de medicamento registrado pela ANVISA, e cujo tratamento consta nas indicações previstas na bula, máxime quando o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento. 4. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado

no paciente. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1725451 (https://jurisdf.tjdft.jus.br/acordaos/9d476dfe-660e-44f2-82dc-a829f0428cb1), 0742832-66.2022.8.07.0001 (https://pje-interno.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/220713221), Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 18/07/2023.)

A conduta da ré **viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana**, além de impor risco à saúde e à vida da autora, que se encontrava em quadro de recidiva da doença, necessitando de intervenção medicamentosa urgente, como demonstrado nos exames laboratoriais e relatórios médicos juntados aos autos.

Ressalte-se que eventual **inclusão posterior do medicamento no rol da ANS**, embora relevante, **não afasta a ilicitude da negativa anterior**, tampouco afeta o interesse processual, já que a autora **só obteve acesso ao tratamento em razão da medida judicial deferida**. Houve, portanto, legítimo interesse de agir, bem como utilidade da prestação jurisdicional, devendo o feito ser **julgado com resolução de mérito**.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. **Confirmar a tutela de urgência** anteriormente deferida, tornando-a definitiva;

2. **Condenar a parte ré a manter o fornecimento do medicamento Benlysta (Belimumabe)**, conforme prescrição médica, pelo tempo que perdurar a necessidade clínica da parte autora, devidamente atestada por profissional habilitado;

3. Condenar a ré ao **pagamento das custas processuais** e **honorários advocatícios**, que fixo em **10% (dez por cento)** sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos.

Sentença publicada eletronicamente. R. I.

Gama, DF, 09 de setembro de 2025

Assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito abaixo identificado(a).

Assinado eletronicamente por: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
09/09/2025 17:23:59
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25090917235909100000226 4

IMPRIMIR GERAR PDF